

Fecha Última Actualización: 06-04-2022 15:39:33

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Jaime Francisco Riquelme Poblete
Edad : 66a 5m 12d
Dirección : Sargento Menadier 3345

Rut : 7.512.226-8
Fecha Nacto: 25/10/1955
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2203016
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 4490 9873

N° Epicrisis
302247

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim

Fecha Ingreso : 29/03/2022 21:01

Días Estadía : 8

Unidad de Egreso : Utim

Fecha Egreso : 06/04/2022 10:04

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Neumonía Bacteriana

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Antecedentes

- Médicos: HTA, DM2 NIR, ICC FEVI 47%, TEP reciente en contexto de SDRA por COVID.
- Quirúrgicos: Apendicectomía.
- Fármacos: Metformina/Vildagliptina 1 comp almuerzo y cena, Aspirina 100 mg, Xarelto 15 mg cada 12 h.
- Alergias (-)
- Hábitos: TBQ (-), OH, drogas (-)
- Inmunizaciones: (-)
- Hospitalizaciones: 16/02 - 09/03 por COVID grave, con VMI aprox. 2 semanas, TEP, bacteremia por S. anginosus e ITU por K. aerogenes. De alta con UHD.

Historia de ingreso:

Paciente con hospitalización reciente por neumonía COVID, de alta con UHD, con destete de O2 consolidado hace más de 1 semana. Consulta por cuadro de 5 días de evolución de disnea progresiva, hasta el reposo, asociado a tos con expectoración mucosa, sin fiebre, sin calosfríos, sin dolor costal, sin molestias urinarias. Ingresa al SU con FC 113, PA 116/78, T 36.3, sat 94 % con 2 L. Se describe con MP globalmente disminuido, crépitos bibasales y sibilancias, sin otros hallazgos. Al laboratorio destaca láctico 19, Crea 0.57, GB 9.770, PCR 175. AngioTAC informa cardiomegalia y secuelas de neumpatía multifocal previa, sin poder descartar un componente sobre agregado de edema pulmonar. Evoluciona con requerimientos de O2 al alza hasta CNAF 60/35%, por lo que ingresa a UTIM.

Diagnósticos

- Insuficiencia respiratoria aguda
- Neumonía AAS
- Antecedentes

Evolución:

- Hemodinamia/Cardíaco: Destaca tendencia a la taquicardia, interpretada en contexto de TEP reciente y desacondicionamiento por miopatía en recuperación. Pendiente ajuste progresivo de tratamientos para ICC FEVI 47%, según tolerancia y seguimiento ambulatorio por cardiología.
- Ventilatorio: Ingresa por insuficiencia respiratoria en contexto de neumonía, evolucionando con requerimientos de O2 hasta CNAF, la cual desteta más de 48 horas previo al alta. Actualmente en destete de O2, con 2 L, sin disnea, en plan de consolidar

Fecha Epicrisis : 06/04/2022 15:39

Página 1 de 2

Fecha Última Actualización: 06-04-2022 15:39:33

Página 2 de 2

con hosp. domiciliaria.

- Infeccioso: Cursa con neumonía clínicamente, sin evidencia al TAC, sin microbiología aislada. Se maneja con Imipenem por 7 días, con buena respuesta.
- Vascular: Se mantiene anticoagulado con HBPM. Al alta puede reiniciar Xarelto, ya dispensado en hospitalización anterior, en plan de completar 3 meses.

Diagnóstico de Egreso

Neumonía Bacteriana, No Especificada -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

En BCG, HDN estable, afebril, req. O2 2 L.

Plan Post Alta

UHD para kinesioterapia motora, respiratoria y destete O2.

Reposo relativo

Régimen hiposódico, 200 g hidratos de carbono

O2 para saturar 92%

Fármacos: Continuar con medicamentos indicados en alta previa (sin cambios).

- Metformina/Vidagliptina 1 comprimido al almuerzo y cena

- Aspirina 1 comprimido al día

- Rivaroxaban (Xarelto) 1 comp de 20 mg al día (usar esquema indicado por TACO, en caso de discordancia), completar un total de 3 meses desde su inicio en hospitalización previa.

Seguimiento:

- Solicitar hora en cardiología (Pasillo 8 CDT) con interconsulta entregada.

Reconsultar en caso de fiebre (38°), dificultad para respirar, sangrado, dolor torácico o según estime necesario.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

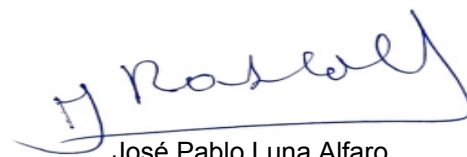
Régimen Alimentario : Con 200 G De Hidratos De Carbono

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



José Pablo Luna Alfaro
Médico Tratante (Staff)